



ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

Incremento del riesgo de ocurrencia de casos importados de sarampión

CÓDIGO: AE – DEVE N° 006- 2015

I. Objetivo

Alertar a los servicios de salud del país ante el incremento del riesgo de ocurrencia de casos importados de sarampión, y su posible reintroducción al país ante la reciente transmisión de casos autóctonos de sarampión en Chile, por el desplazamiento de peruanos hacia y desde ese país con motivo de la celebración de la Copa América 2015.

II. Antecedentes

La región de las Américas logró interrumpir la transmisión endémica del virus del sarampión en el 2002 y rubéola en el año 2009. En el Perú se notificó el último caso autóctono de sarampión en 2000 y el último caso de rubéola en 2006. En abril de 2015 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró que la rubéola se había eliminado del continente americano.

III. Situación actual

En el año 2014 se reportaron 201,499 casos de sarampión a nivel mundial, distribuidos en el 63,4% (123) de los países del mundo, siendo las regiones más afectadas: Pacífico Occidental con 118, 934 (59%). La región de las Américas reportó 1868 casos de sarampión, Brasil reportó el 37,9% (708), Estados Unidos 34,5% (644), Canadá 27,4% (512), México dos casos, Argentina y CRI un caso respectivamente. (1). En 2015, la OMS informó hasta el 5 de mayo 35,981 casos, de los cuales el 40,3% proceden de la Región Pacífico occidental, 40% de África, 9,7% de la Región Mediterráneo este, 4,9% de Europa, 3,8% de la Región de Sudeste de Asia y el 1,3% de América.

En la Región de las Américas, hasta la SE 22 de 2015, se han reportado 520 casos de sarampión, 145 en Brasil, todos ellos de fuente de infección conocida; 195 casos en Canadá, 174 en Estados Unidos, cinco en Chile y uno en México (2). Los Estados Unidos experimentan un brote multietatista relacionado con el parque de diversiones Disneylandia en California, el cual representaba el 68% de los casos hasta el 29 de mayo (3), el último caso reportado fue en la SE 21. Brasil presenta transmisión de casos desde 2013 en forma consecutiva. Chile actualmente presenta un brote de sarampión de 5 casos, que inició el 12 de mayo de 2015, en residentes de Santiago, capital del país; en todos los casos a excepción del primero, se ha identificado el Genotipo H1, que circula en Asia, incluyendo China (2).

El turismo en América Latina se incrementó en los últimos años. En 2014, el Perú llegó a recibir a 3'214,054 turistas extranjeros; en el presente año Machu Picchu ha sido considerado como el segundo lugar de mayor interés turístico del mundo. La Copa América 2015 se está llevando a cabo en Chile desde el 11 junio y durará hasta el 4 de julio, lo que motivará el viaje de numerosos connacionales y extranjeros hacia Chile y su posterior retorno. Otro evento que se llevará a cabo en las Américas es la visita del Papa Francisco que visitará Paraguay y Bolivia desde del 8 al 12 de julio, que convocará la asistencia de muchos peregrinos de la región.

El Perú en los últimos años ha implementado acciones de protección contra el sarampión y rubéola, como la campaña de vacunación del 2006, en la que se alcanzó coberturas de vacunación en el grupo poblacional de 20 a 29 años de 92%, cohorte que actualmente tiene entre 29 a 38 años de edad, por lo cual existe población susceptible.

El elevado riesgo de presentar un caso importado de sarampión o rubéola en el país determina la probabilidad de que se instale la transmisión autóctona nuevamente a la acumulación de población susceptible a sarampión y rubéola por coberturas de vacunación no óptimas alcanzadas en los últimos años.

Considerando el contexto actual, la Dirección General de Epidemiología recomienda diversas acciones de prevención y contención ante la posible presentación de casos importados de sarampión y rubéola.





III.- Recomendaciones

Las GERESA/DIRESA/DISA del país, redes y establecimientos de salud deben fortalecer las actividades de vigilancia y prevención implementando las siguientes recomendaciones:

1. Difusión de la Directiva Sanitaria N° 049 – MINSA/DGE-V.01 para la vigilancia de sarampión, rubéola y otras enfermedades febriles eruptivas entre todos los trabajadores de salud, especialmente los profesionales y técnicos encargados de la atención de pacientes. Esto incluye la difusión de la definición de caso sospechoso de sarampión/rubéola: "Toda persona de cualquier edad, de quién un trabajador de salud sospecha que tiene sarampión o rubéola, o todo caso que presente fiebre y erupción máculo-papular generalizada, **no vesicular**"
2. Todo trabajador de los servicios de salud del país, al identificar un paciente que cumpla la definición de caso sospechoso de sarampión/rubéola debe comunicarlo inmediatamente al encargado de epidemiología o quien haga sus veces en el establecimiento de salud.
3. Ante la detección de un caso sospechoso, el responsable de epidemiología o quien haga sus veces, deberá notificarlo inmediatamente y llenar la ficha clínica epidemiológica, debiendo realizar la investigación dentro de las 48 horas de conocido el caso, así como disponer la toma de muestra de suero y del hisopado nasofaríngeo al primer contacto con el caso y envío al Laboratorio Referencial Regional, según las especificaciones de la D.S. 049-2012/MINSA.
4. El responsable local de epidemiología liderará las acciones de investigación, seguimiento de contactos y bloqueo ante un caso sospechoso o conglomerado de casos sospechosos de sarampión, según la D.S. 049-MINSA/DGE-V.01, en coordinación con el equipo técnico local. Debe recibir el apoyo y asistencia técnica del nivel inmediato superior, lo cual comprende la evaluación del riesgo y de los recursos con que se cuenta para las acciones de control.
5. Cada GERESA/DIRESA/DISA, debe fortalecer la capacidad de identificación y reporte de todo caso febril eruptivo atendido en las entidades del sector salud, del ámbito público y privado. Es importante lograr la participación del sector privado en la vigilancia epidemiológica de sarampión, debido a la mayor probabilidad de que los viajeros internacionales busquen atención en establecimientos de salud privados.
6. Difundir entre la población la necesidad de estar vacunados contra sarampión y rubeola, con énfasis en las personas que tienen contacto directo con personas procedentes o que viajan a países con transmisión actual (Chile, Brasil, Estados Unidos y fuera del continente, mediante avisos al público en aeropuertos, puertos, estaciones de bus, agencias de transporte y de viajes. Considerar que los viajes a Chile aumentarán especialmente por la celebración de la Copa América en dicho país.
7. A las personas cualquier edad que no fueron vacunadas anteriormente o menor de 5 años que no tienen su calendario de vacunación contra sarampión completo y van a viajar a países con transmisión de sarampión se les debe recomendar que se vacunen al menos dos semanas antes del viaje.
8. Recomendar a las personas que retornan de Chile, Brasil, Estados Unidos o de otros continentes con transmisión, que si presentan fiebre y erupción, dentro de un periodo de hasta 20 días después de retornar al país, solicitar evaluación por un médico en un servicio de salud. Según la evaluación se podrá determinar el aislamiento de la persona si fuera un caso sospechoso de sarampión.
9. A las GERESA/DIRESA/DISA: difundir la presente alerta para su implementación en todos los establecimientos de salud públicos y privados en su ámbito de su jurisdicción.

Lima, 14 de junio de 2015

Referencias bibliográficas:

1. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monitoring_data/en/
2. OPS: Boletín Semanal de Sarampión/Rubeola Vol. 21, N°22
3. <http://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks-sp.html>

